

Lp(a)·아포B — 2026년에 새로 보는 혈관 위험 검사

콜레스테롤(LDL)과는 별도로 혈관 위험을 보여주는 두 가지 혈액검사입니다. Lp(a)는 타고난 유전 수치, 아포B는 혈관벽에 쌓일 수 있는 입자의 개수를 반영합니다.

한눈에 보는 핵심 수치

유전 기여도

90% ↑

운동·식사로 거의 변하지 않음

LP(A) 저위험

<75

nmol/L

LP(A) 고위험

≥125

nmol/L

검사 권장

평생 한 번

성인기 — 경계치·상태 변화 시
재검 고려

두 검사가 각각 보는 것

LP(A) — 유전으로 정해지는 수치

90% 이상 유전으로 정해지는 지질 입자로, LDL 콜레스테롤과 따로 측정합니다

운동이나 식사를 바꿔도 크게 변하지 않아 **평생 한 번** 검사합니다

높다면 **부모·형제자매·자녀**도 검사를 상담해 보세요
결과지의 단위(**mg/dL** 또는 **nmol/L**)를 꼭 확인해야 합니다

아포B — 혈관벽에 쌓일 수 있는 입자의 수

LDL을 포함해 혈관벽에 쌓일 수 있는 입자마다 하나씩 붙는 단백질입니다

작고 치밀한 LDL이 많을 때 LDL 콜레스테롤 수치보다 위험을 더 잘 보여줄 수 있습니다

아포B와 아포A 비율을 함께 참고하기도 합니다

LDL 수치가 정상이어도 아포B가 높으면 남은 위험이 있을 수 있습니다

결과가 높다면

함께 관리하는 것

LDL 콜레스테롤 목표를 더 엄격하게 관리합니다

금연은 특히 중요합니다

혈압·혈당 등 다른 위험요인도 함께 확인합니다

정기 진료로 전체 혈관 위험도를 재평가합니다

아직 정해지지 않은 것

Lp(a) 자체를 낮추는 용도로 **승인된 약은 아직 없습니다**

여러 새로운 약이 **임상시험 단계**에 있습니다

Lp(a) 관리를 위해 영양제·보충제를 복용하는 것은 권장하지 않습니다

운동만으로 수치가 크게 떨어지지 않습니다

이럴 땐 바로 응급실로

Lp(a)·아포B 수치가 높다는 것 자체는 응급 증상이 아닙니다. 다만 갑자기 심한 가슴 통증, 팔다리 마비나 힘 빠짐, 말이 어눌해짐, 심한 호흡곤란이 있으면 결과 설명을 기다리지 말고 바로 응급실로 가시거나 119에 연락하세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 2022 EAS Lp(a) 합의문 · 한국지질·동맥경화학회 Lp(a) 입장문 2026 · 2026 ACC/AHA 이상지질혈증 가이드라인 · 2024 NLA 아포B 임상 컨센서스

본 자료는 공통 설명용입니다. 실제 목표 수치와 약물 선택은 전체 위험도, 기존 질환, 가족력에 따라 달라집니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/lpa-apob/